SEEG（定位的頭蓋内脳波）が有用であった難治性てんかんの 1 例

◎鈴木 碧[1)]、岡田 真実[1)]、谷髙 由利子[1)]、金子 洋子[1)]、福田 淳[1)]
社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院[1)]

【背景】
難治性てんかんにおいて発作焦点の同定は外科的治療の適応判断に重要である。従来の頭蓋内脳波検査は開頭による電極留置を要するが、2020 年に保険収載された SEEG（定位的頭蓋内脳波）は開頭を必要とせず、患者負担が少ない。今回、SEEG により発作焦点を同定し得た難治性てんかんの 1 例を経験したため報告する。
【症例】
患者は 10 歳代後半男性。4 歳よりてんかん発作を認め、以後複数の抗てんかん薬を試みるも発作の完全抑制には至っていなかった。MRI では両側大脳半球に限局性構造異常を認め、結節の存在が示唆された。当院で実施した長時間ビデオ脳波検査では左側頭葉の結節付近に焦点が推定されたが特定には至らなかった。
【方法・経過】
発作焦点の同定を目的に SEEG を施行した。検査技師は、SEEG 電極留置術時の術中脳波モニタリングに立ち会い、帰室後より SEEG モニタリングを開始した。モニタリング期間中は毎日脳波波形を確認し、発作およびてんかん性放電の有無を評価して医師へ報告した。また、病室での電極状態の確認を行うなど、病棟看護師と連携しながら継続的なモニタリングを実施した。
【結果】
SEEG モニタリング中に 6 回の過運動発作を認め、いずれも左側頭葉結節または左側頭葉先端から開始する発作時脳波を認めた。その後、医師が実施した発作誘発検査により、左側頭葉結節への刺激でてんかん波が誘発され、発作焦点は左側頭葉結節と同定した。今年 3 月に発作焦点切除術が行われ、術後 2 ヶ月時点で再発作を認めていない。
【考察・結論】
本症例では、長時間ビデオ脳波検査のみでは発作焦点の特定が困難であったが、SEEG により焦点を同定することができ、外科的治療方針の決定に大きく寄与した。SEEG は難治性てんかんの焦点特定において極めて有用な手段であると考えられた。

連絡先：053-436-1251（内線 3560）